

L'interrogatoire en pneumologie

Dr. N. IDRI

Objectifs pédagogiques :

- S'avoir mené un interrogatoire
- Connaître les différentes étapes de l'interrogatoire.
- Connaître le motif de consultation et décrire les différents symptômes
- Chercher les facteurs de risque

Plan du cours :

1. Introduction
2. Les données de l'état civil
3. Le motif de consultation
4. L'histoire de la maladie
5. L'histoire professionnelle
6. Les antécédents personnels
7. Les antécédents familiaux.
8. Les habitudes toxiques

L'interrogatoire en pneumologie

Dr. N. IDRI

1. Introduction :

L'interrogatoire est le premier temps de l'examen clinique, c'est une étape essentielle qui permet d'orienter l'examen physique et la demande des examens complémentaires.

Pour qu'un interrogatoire soit fructueux il faut que certaines conditions soient remplies :

- le soignant (médecin ou étudiant) doit se présenter au patient en précisant son nom et sa fonction, sa tenue doit être correcte.
- le lieu de l'interrogatoire doit respecter la confidentialité, le patient doit être confortablement installé. Lorsque l'interrogatoire est réalisé au lit du malade, il est indispensable de demander aux visiteurs de sortir.
- Poser des questions faciles à comprendre, être poli, respectueux, attentif, observer les expressions du visage et du corps, utiliser le langage corporel (sourire, silence, regard...).
- Orienter l'interrogatoire (commencer par des questions ouvertes puis surtout des questions fermées), ne pas imposer ses propres conceptions.

Certaines situations cliniques rendent l'interrogatoire impossible (coma, démence, troubles de l'élocution). Il faut alors chercher à réunir les éléments de l'anamnèse en interrogeant l'entourage et/ou le médecin traitant.

2. Les données de l'état civil :

Sont recueillis par le médecin ou au préalable par un secrétaire ou un infirmier.

- L'interrogatoire précise **le nom et le prénom du patient**.
- **La date de naissance** : la prévalence des pathologies est influencée par l'âge : les sujets jeunes développent plus volontiers des pathologies traumatiques, infectieuses ou génétiques, tandis que les pathologies dégénératives ou tumorales sont plus fréquentes chez les sujets âgés,
- **L'origine ethnique** : certaines populations sont exposées à des pathologies infectieuses : tuberculose (Afrique, Asie), à des pathologies génétiques (anomalies de l'hémoglobine par exemple fréquentes en Afrique).
- **La profession et les conditions socio-économiques du patient** : cet aspect est particulièrement important à considérer. Certains modes de vie exposent à la promiscuité et favorisent la contamination inter individuelle d'agents infectieux (tuberculose). Il faut préciser sa vie sociale, ses revenus, ses moyens de locomotion. L'existence d'animaux domestique (pneumallergènes, ou suspicion d'un kyste hydatique).

3. Le motif de consultation :

- **Le plus souvent un symptôme :**

Sa description est parfois difficile, **une dyspnée** (perception pénible de la respiration) peut être décrite de différentes manières par le malade : essoufflement, oppression thoracique, gêne respiratoire, fatigue à l'effort, ... Le rôle du médecin est de faire préciser chaque terme employé par le patient et au besoin de les reformuler.

- Lorsque les plaintes sont multiples, il est utile de hiérarchiser les symptômes, soit en : fonction de leur chronologie d'apparition, leur intensité ou de l'importance qu'elles revêtent pour le patient, ou en fonction de l'organe auquel elles semblent se rapporter.

- **Le motif de consultation peut être la découverte d'une image radiologique anormale.** Il faut alors préciser l'ancienneté de l'image anormale : Il est indispensable de consulter les documents antérieurs afin d'évaluer l'évolution de cette image ; rechercher les symptômes d'accompagnement (inconstants). Dans tous les cas, l'interrogatoire doit être complet en suivant les mêmes étapes.

- **Enfin, la consultation peut être motivée par un dépistage** dans l'entourage d'un malade atteint d'une maladie infectieuse (tuberculose) ou génétique (mucoviscidose)...

4. L'histoire de la maladie :

- **La date d'apparition** Souvent difficile d'obtenir la date précise du début sauf lorsque le symptôme est d'apparition récente ou qu'il est apparu de manière très bruyante. A défaut de date précise il faudra s'attacher à rechercher le nombre de jours, de mois ou d'années par rapport à la date d'admission à l'hôpital ou par rapport à la première consultation. On pourra aider le malade en lui suggérant des repères connus : les fêtes religieuses, la date du mariage, la date de naissance des différents enfants.

- **La nature du symptôme :** Si nous prenons comme exemple de motif de consultation la douleur, il faut faire préciser au malade le type de cette douleur : torsion, brûlure, déchirure...

- **Le mode de début** Qui peut être brutal ou progressif.

- **Les facteurs déclenchant :** Des troubles affectifs, l'activité physique, les repas, la prise de certains médicaments...

- **Les facteurs sédatifs** Le repos, la prise de certains médicaments.

- **La localisation d'éventuelles irradiations** Ce caractère est à rechercher surtout lorsque le symptôme signalé par le malade est à type de douleur. On demandera au malade de désigner avec le doigt le point où la douleur est maximale.

- **L'évolution** dans le temps qui peut être permanente ou intermittente ; il est également nécessaire de savoir si le symptôme s'est aggravé dans le temps : s'il a augmenté d'intensité ou de fréquence et s'il a été influencé par des traitements en faisant alors préciser leur nature exacte.

- **Les symptômes thoraciques et extra thoraciques associés** (la notion de céphalée, d'hémorragies extériorisées, de toux, de dyspnée, de troubles urinaires, d'œdèmes...) et l'ordre chronologique de leur apparition par rapport au symptôme principal.

- **Le contexte général** dans lequel ils sont apparus : contexte infectieux avec fièvre, altération de l'état général.

En effet, un malade peut présenter plusieurs problèmes mais souvent la maladie actuelle a tendance à lui faire oublier ses autres ennuis qui sont d'autant plus nombreux que le malade est plus âgé.

5. L'histoire professionnelle :

- Notion très importante,
- L'inhalation de certaines substances physico-chimiques : substances volatiles (gaz et vapeurs toxiques et/ou irritants), particules solides inertes (charbon) ou actives (silice).
- Un véritable calendrier professionnel devra être établi, précisant la durée et degré d'exposition, Secteur d'activité, postes de travail occupés, produits manipulés et substances auxquelles le sujet a pu être exposé

6. Les antécédents personnels :

- Physiologiques :

- Vérifier si le patient est vacciné au BCG
- Les épisodes de la vie génitale chez la femme : La ménarche, Le cycle mensuel, la durée du cycle mensuel, la durée des règles et leur abondance, les grossesses, les avortements, la ménopause...

- Pathologiques :

*** Il est indispensable d'intégrer le symptôme dans l'histoire médicale du patient :**

- Les symptômes peuvent être en rapport avec l'évolution d'une affection connue, exemple une dyspnée révélant une embolie pulmonaire chez un patient connu un cancer du côlon.
- Les symptômes peuvent être en rapport avec des séquelles d'une maladie "guérie" ; exemple une dyspnée révélant une fibrose pulmonaire, séquelle d'une tuberculose pulmonaire correctement traitée et guérie.
- Les symptômes peuvent être en rapport avec des complications iatrogènes ; exemple d'une dyspnée révélant une fibrose pulmonaire secondaire à une irradiation thoracique.

*** Les antécédents médicaux**

- Il est pratique d'explorer les antécédents médicaux organes par organe afin de n'en méconnaître aucun : Avez-vous eu d'autres maladies du cœur, des articulations, de l'estomac ou des intestins ...
- L'interrogatoire doit préciser les antécédents allergiques (symptômes, allergènes incriminés, traitements entrepris). En cas d'allergie médicamenteuse (antibiotiques, anesthésiques...), il est capital de l'indiquer sur la page de garde du dossier médical du patient.
- Il faudra, en fin d'interrogatoire, vérifier les ordonnances pour s'assurer de la pertinence de l'interrogatoire.

*** Les antécédents chirurgicaux :**

Il importe de faire préciser : le motif de l'intervention, la date de l'intervention, le type d'intervention chirurgicale (certaines interventions peuvent modifier profondément la physiologie de l'organe), les complications post-opératoires éventuelles.

Il faut se méfier des explications rassurantes (+++) : "On m'a enlevé un kyste au sein", "J'ai été opéré d'un polype aux intestins".

Il est utile de vérifier les cicatrices pour s'assurer de la pertinence de l'interrogatoire.

Enfin, il est indispensable de récupérer les comptes-rendus chirurgicaux et anatomo-pathologiques.

7. Les antécédents familiaux

- On recherchera systématiquement l'existence dans la famille de certaines maladies : diabète sucré, hypertension artérielle, cancer, certaines maladies sanguines (hémophilie, anémie hémolytique), l'obésité, les manifestations allergiques (asthme, urticaire) ; les affections coronariennes....

- Un contexte de pathologies génétiques doit être recherché notamment chez les sujets jeunes : Mucoviscidose, l'emphysème par déficit en alpha 1 antitrypsine (α 1-AT), certains déficits de facteurs de la coagulation familiaux provoquent des thromboses itératives et des embolies pulmonaires.

8. Les habitudes toxiques :

***Alcool**

*** Tabac :**

- La consommation du tabac est un facteur de risque majeur, c'est le principal facteur de risque respiratoire qui est responsable de la quasi-totalité des cancers bronchiques et des BPCO.

- Il peut être actif ou passif

-Le tabagisme retrouvé doit être quantifié, chiffrée en paquets/année soit le nombre de paquets quotidiennement fumés multiplié par le nombre d'années de tabagisme, filtres ou sans filtre, blondes ou brunes, le degré de dépendance grâce à l'échelle de Fagerström

* Il faut rechercher également : la consommation de **cannabis** qui peut être associée au tabac

Conclusion :

L'interrogatoire est une étape fondamentale de la prise en charge du malade

Sous réserve de respecter ces règles simples, un diagnostic sera établi par l'interrogatoire dans plus de trois quart des cas.

Références :

François LEBARGY, Sandra DURY, Olivier TOUBAS. Référentiel sémiologie - Collège des Enseignants de Pneumologie 2009, pp5-8 Rose maris Hamladji sémiologie